

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	預防病人跌倒作業標準 Operating Standards to Prevent Patient Falls				
編號	A31000-Q02-W-H02	制定者	R14 卓瑞萍	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 4.7 版/16 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解預防病人跌倒原則，教導病人和照護者能知悉跌倒的因素，並正確的執行預防方法，及早確認具高度危險傾向的病人與環境，提供安全的治療環境，預防病人意外跌倒發生，提昇病人照護安全。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）原則：

1. 製訂「預防病人跌倒標準作業流程」並確實執行。
2. 定期執行病人預防跌倒之安全宣導。
3. 針對護理人員在病人跌倒預防部份進行定期稽核。
4. 病人入院或轉入 8 小時內、病情改變（意識、肢體活動改變、發生跌倒、全麻手術後）及出院前 24 小時，由負責護理人員登入 HIS 系統跌倒危險因子評估進行評估，若無上述情況，則依評值原則每週定期評值。急診病人一律視為高危險病人佩戴粉紅色手圈；門診病人若執行侵入性治療或檢查結束離院前，檢查單位會進行跌倒危險因子評估及提供個別之護理措施。
5. ≥65 歲以上病人，於入院或轉入病房 72 小時內，由負責護理人員登入 HIS 系統進行衰弱評估，若任 1 項「是」得 1 分，為衰弱前期(Pre-Frailty)，護理人員需給予衰弱衛教指導。若入院或轉入病房 72 小時內評估無衰弱風險（總分 0 分），則於出院前須進行再評估。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	2/16

項目	流程說明	備註
入院或轉入	8 小時內依 HIS 系統工作清單之「跌倒危險因子評估表」進行評估。72 小時內進行「衰弱評估」。	跌倒定義：病人因意外跌落至地面或其它平面。
收案	當病人跌倒危險因子評估結果總分成人、小兒科 ≥ 4 分則為跌倒高危險群。衰弱評估 1 分為衰弱前期(Pre-Frailty)。	
措施	1. 當病人跌倒危險因子評估結果總分成人、小兒科 ≥ 4 分，擬定預防高危險群跌倒措施，為病人戴上粉紅色手圈及在床頭貼上防跌標語（附件一），並告知其為高危險群跌倒病人，其發生跌倒的機率比較大，所以要特別小心，但復健病房病人 ≥ 7 分才在床頭貼上防跌標語（附件一）。衰弱評估 1 分為衰弱前期(Pre-Frailty)，需給予衰弱衛教指導。 2. 護理人員應將高危險跌倒病人列入交班事項，並提供病人或照顧者個別性護理指導及護理指導單張。 3. 內容涵蓋病人個人的照護、安全環境的維護、藥物調整及跌倒後檢視及調整照護計畫。	核醫大樓病房 PIT 系統會顯示「預防跌倒」，故不需再貼上防跌標語。
定期評值及追蹤	1. 每週定期評值或病情改變時重新跌倒危險因子評估。 2. 當病人轉入或發生跌倒時應重新跌倒危險因子評估。 3. 病人出院前 24 小時應重新跌倒危險因子評估。 4. 若入院或轉入病房 72 小時內衰弱評估無衰弱風險（總分 0 分），於出院前須進行再評估。	
結案	出院、轉院、自動出院、expired 可結案。	

（二）預防跌倒措施涵蓋病人個人的照護、安全環境的維護、藥物調整、跌倒後檢視及調整照護計畫及出院後加強防跌衛教事項。

1. 病人個人照護部份：

- (1) 病人若下床進行活動時，應有人陪伴並於病人左右側協助扶持，教導病人及照顧者正確下床方式，如右側偏癱者應由左側下床。
- (2) 照護團隊應依病人個別性隨時評估有無可改變的跌倒因子，如調整藥品、改善視力、姿勢性低血壓處置或提供適當輔具使用，以避免跌倒的發生。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	3/16

- (3)護理人員應教導高危險群病人（如頭暈、血壓不穩、服用鎮靜安眠藥）之照顧者，需預防因姿勢改變引起低血壓狀況，於轉換姿勢時應採漸進式方式，起身時動作放慢、或是改變姿勢時需先坐著休息 1~2 分鐘後再起來。
- (4)病人下床活動時，協助病人使用床欄或支撐物支撐，且讓病人與照顧者瞭解上下床（輪椅）及使用輔具之安全步驟。
- (5)若照顧者是採取輪班制或不固定人員照顧病人時，應告知照顧者換班時，要口頭或書面交班，照顧期間須特別注意的事項。
- (6)建議病人晚上睡前儘量少飲水，避免晚上因下床上廁所，而造成跌倒的危險性增高。
- (7)教導照顧者下床轉位技巧前，先測試下肢肌力，以確認肢體支撐力之足夠，必要時會診復健科進行肌力或平衡相關訓練（如：上肢抓握能力、下肢承重肌力訓練、臥床抬臀等訓練），並確認肢體支撐力之足夠，方可教導照顧者協助病人轉位、下床行走及使用輔具等照護技巧。
- (8)當病人入院臥床時，第一次下床時應執行步態平衡測試，並衛教及教導病人及照顧者採漸進式下床。
- A.步態平衡測試(Timed get up and go test, TUG)，於過程中觀察受檢者的穩定度與步態。
- B.首先請受檢者坐在直背的椅子上，然後請病人站起，依照平常習慣速度往前走三公尺，轉身回到椅子上再坐下。
- C.整個過程平均為 15 秒，若超過 20 秒，則需進一步評估。
- (9)衛教病人應穿著大小合適之衣褲及防滑且大小適宜的鞋子，以免造成絆倒或滑倒。
- (10)護理人員對於身體虛弱、下肢無力、行動不便病人者，應於床邊放置便盆椅、尿壺，方便病人如廁。若有脊髓損傷或膝關節受損之病人，可採用高位活動便盆椅，上述之病人如廁過程均需全程陪伴。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	4/16

- (11)強化病人對自身跌倒危險因子之認知，護理人員需衛教病人及家屬目前是跌倒高危險群，容易發生跌倒及意外，告知若需要協助時務必尋求護理人員協助。
- (12)教導照顧者要離開前，請先協助病人完成喝水、上廁所、下床等需求，再行離開。
- (13)除了行進中的輪椅外，未使用的輪椅一定要固定，避免突然滑動，造成意外發生。
- (14)針對年長者提供預防跌倒措施或護理指導時，護理人員需以討論方式徵詢意見，以尊重其感受。
- (15)針對視障、聽障病人提供預防跌倒措施或護理指導時，除搭配紙和筆進行溝通外，亦請其照顧者在旁協助傳達並陪伴，確保住院期間的安全。
- (16)衛教病人及照顧者，入院時應將隨身物品例如輔具、眼鏡（如老花眼鏡）、助聽器及..等帶來醫院，方便日常活動使用，預防跌倒發生。
- (17)考量孕婦因妊娠時本體感覺降低、重心較不穩定、頭暈等不適情形或分娩期間因子宮收縮及產痛加劇等因素，容易發生跌倒意外，故衛教孕婦及陪伴者，臥床或久坐起身時，務必採漸進的方式改變姿勢（側臥→坐臥→起身），動作放慢，並尋找支撐物輔助；行走時，應穿著防滑平底鞋，可以攙扶走道扶手步態應緩慢；當行走中有不舒服或頭暈現象，應就近找尋支撐物支撐或蹲下、坐下或臥床休息。
- (18)病人若為跌倒高危險群，至檢查室、手術室、手術恢復室或轉床時，應確實交班並防範病人跌倒。
- (19)若病人本身為獨居，住院中請照顧者增加探視病人次數，評估病人有社福需求，則適時轉介社工師，並在病人住院 2 個工作天內，由出院準備服務護理師進行訪視，當個案符合長照身分別，則於住院中進行長照需求評估，轉介長照居家服務或居家無障礙環境評估，以提升病人生活品質及減少跌倒之風險。衰弱評估 ≥ 2 分為衰弱期(Frailty)，轉介至地方政府之長期照顧管理中心，進一步

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	5/16

評估與安排至特約單位接受衛生福利部長期照顧十年計畫 2.0 之「預防及延緩失能照護服務」。

2.安全環境部份：

- (1)主動將病人可能使用的物品，如輔具、眼鏡、拖鞋、床旁叫人鈴拉線、尿壺等，置於病人隨手可得之處。
- (2)年長者輔具的使用（如：床欄、夜燈、呼叫鈴、便盆椅等），需確認年長者可正確使用。
- (3)高危險群病人（失智、無家屬陪伴、高齡 70 歲以上或有多次跌倒史之病人）需增加探視的次數或使用下床感應式呼叫鈴並安排病床靠近護理站處方便照護。
- (4)病人於床上休息時，病床高度應降至病人坐於床緣時可雙腳著地，以防起身反作用力前傾跌倒之風險，床輪應置於固定位置且定期檢測其功能。
- (5)對於躁動不安、意識不清高危險群跌倒病人，評估造成病人躁動不安的原因，並給予適當保護措施。
- (6)依病人身體活動需求，主動提供床欄及輔具使用，並教導正確的使用方法，隨時檢修病房床欄有無損壞情形，若有損壞，則立即請修。
- (7)病人欲起身站立時，支撐時避免使用會傾斜或可能會滑動的傢俱，如床旁桌或帶輪點滴架，教導家屬下床時可使用移位固定帶。
- (8)病房與浴廁地面應隨時保持乾燥，特別是病床至浴廁間通道要無障礙物及充足的照明（如：夜燈或地燈），若地面潮濕時則需設置警示標誌。
- (9)浴廁加裝止滑設施、扶手及叫人鈴，且設有扶手供病人使用。
- (10)清潔人員洗地或拖地時，應告知走道要先洗(拖)一邊待地面乾燥後，再洗(拖)另一邊地板，洗(拖)地前應先告知病人或家屬。
- (11)兒科病人儘可能使用兒科病床，衛教照顧者，兒童病床床欄正確使用方式並有操作圖示張貼於醫療牆上，病人於床上時，請隨時將兩側床欄拉起至最高並

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	6/16

固定，床欄杆若縫隙太大，可用硬枕頭或棉被堵住以防跌落，床體高度平時維持在最低位置，床輪於靜止狀態應予固定，避免滑動，若需下床時，應先將床欄放下勿翻越。

(12)衛教兒科照顧者，病人若如廁所或沐浴時，應先將用物準備齊全後，再協助病人至浴廁，以免照顧者離開拿取用物時，造成病人跌倒；提醒照顧者需如廁或沐浴，為了您寶寶安全於入浴室前可向兒科病房護理站借用娃娃車或是您也可請護理站人員暫時照顧娃娃，期能妥善安置病兒，確保病兒父母如廁時之病兒安全。

(13)視環境許可宜將病床一側緊靠牆壁，另一側緊鄰陪客床，以避免病人夜間未喚醒照顧者即自行下床而發生跌倒。

(14)體重計宜加裝扶手，如外圍輔以助行器、底下加裝止滑墊或加強固定。

3.藥物調整部份：

(1)主護護理師於病人住院第一天給予鎮靜安眠藥時須詳加說明藥物可能的作用及注意事項，且於護理紀錄上需確實記載給藥前衛教內容及藥物使用後病人狀況。

(2)針對頻尿或腹瀉病人，應檢視其飲食型態及用藥情形或疾病史如前列腺肥大或尿道感染，應立即與醫師討論，適時照會及處理。

(3)小夜班護理人員主動提醒病人或協助病人臨睡前如廁之需求，特別是睡前服用鎮定安眠麻醉止痛劑者。

(4)病人若因服用藥物（多重用藥）造成步態不穩或跌倒，應立即與醫師討論是否調整藥物並重新檢視藥品使用的必要性。

4.跌倒後檢視及調整照護計畫：

(1)當病人發生跌倒，請先協助將病人先扶到床上休息後，先測量其生命徵象、意識狀態及下肢肌力，並通知醫師前往探視病人，評估並觀察病人當下情形，依醫囑給予傷口護理、縫合、照 X 光及電腦斷層攝影..等處置。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	7/16

(2)病人若有以下任一情況，跌倒後建議需做電腦斷層掃描(CT)檢查。

- A.多重疾病，例：多種慢性病。
- B.有出血傾向病人，或使用血栓溶解劑或抗凝血劑的病人。
- C.跌倒後意識短暫喪失或改變，出現顱內壓上升症狀，例如：噁心、嘔吐等。
- D.有頭部血腫。
- E.抽搐、局部肢體無力。

(3)若經醫師診視，判斷病人有其他相關適應症，有執行電腦斷層掃描之必要，亦可安排檢查。

(4)護理人員應對發生跌倒病人重新再評估危險因子正確與否，並適時調整照護措施。

(5)除上述共通性觀察流程外，需針對不同屬性（高齡、智障、聽障、視障、語言障礙、孕婦等）病人建立跌倒後立即處理及後續觀察流程。例如：

- A.高齡：跌倒發生後，應再次衛教病人及家屬下床活動時務必有人陪伴，若病人要下床如廁，務必陪同至廁所內，勿在門外等候。
- B.智障：跌倒發生後，務必請照顧者在旁陪伴，視情況安排在靠近護理站處等方便照護，增加探視次數。
- C.聽障：因其本身無法清楚聽見別人說話，故跌倒後會主動提供紙和筆與病人進行溝通，請其劃出或寫出身體有無哪裡不舒服，並依其個別性，加強相關預防跌倒衛教措施。
- D.視障：因其本身無法清楚看見眼前之步道，故會有碰撞他人與物品的危險。跌倒發生時，應再次衛教病人及家屬下床活動時務必有人陪伴，病室內空間盡量保持寬敞及移除不必要物品，有任何問題要主動提出。
- E.語言障礙：因為無法清楚表達跌倒及疼痛部位，故建議一定要追蹤 X 光，且增加探視次數，並請照顧者協助說明跌倒部位及發生經過。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	8/16

F.孕婦：每 15 分鐘密切測量生命徵象及評估意識狀態至穩定；監測胎兒心跳及孕婦宮縮情形，持續裝置胎兒監視器至穩定；評估陰道出血及破水情形，必要時給予石蕊試紙測試(Nitrazine paper)，預防早期胎盤剝離、早產、早期破水、產前出血、子宮破裂的情形。

5.出院後加強防跌衛教事項：

- (1)強化病人對自身跌倒危險因子之認知，並告知病人及家屬目前是跌倒高危險群，容易發生跌倒及意外，告知若需要協助時，務必尋求照顧者協助。
- (2)當病人出現意識不清楚或有躁動行為，請照顧者務必有人陪伴在病人身旁，並提供適當保護措施，必要時可返院就醫。
- (3)返家臥床休息最好能將床靠牆，預防因意識不清或躁動而從床上跌落，病人下床進行活動時，應有人陪伴於病人左右側協助扶持。
- (4)不要經常更換傢俱位置，避免病人因不熟悉擺放位置，情急下發生跌倒。
- (5)保持臥室光線明亮，走道建議有夜燈，避免燈光昏暗看不清楚。
- (6)請主動將病人可能使用的物品，如輔具、眼鏡、拖鞋、衛生紙、水杯、尿壺等，置於病人隨手可得之處。
- (7)從床上欲起身，若自覺體力不支時，請勿獨自下床，務必請照顧者協助。
- (8)依病人活動需求，建議購買並教導相關輔具使用（如：輪椅、便盆椅、尿壺及助行器等等），並放置於床旁，方便下床使用。
- (9)教導高危險群病人（如頭暈、血壓不穩、服用鎮靜安眠藥）之家屬，需預防因姿勢改變引起低血壓狀況，於轉換姿勢時應採漸進式方式，起身時動作放慢、或是改變姿勢時需先坐著休息 1~2 分鐘後再起來。
- (10)行走時若自覺有頭暈時，應手扶著牆壁或扶手支撐緩慢坐下，並呼喊照顧者前來協助。
- (11)建議病人晚上睡前儘量少飲水，避免晚上因下床上廁所，而造成跌倒的危險性增高。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	9/16

(12)教導病人睡前先如廁，減少夜間如廁次數。

(13)應注意服藥後副作用，視藥物特性給予個別性衛教，並建議服藥後減少下床，並注意下床活動安全。

(14)若病人本身為獨居，出院後請家屬增加電話關心及探訪次數，若無任何家屬，則連絡社工，請其代為聯絡里長，協助申請生命連線系統，當病人身體不適或發生意外，即可啟動緊急救援機制，確保可獲得協助，並轉介社福相關基金會，提供物資、照顧或陪同就醫等資源，或請里長結合愛鄰守護隊等鄰里社區力量，定時關心病人。

(三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

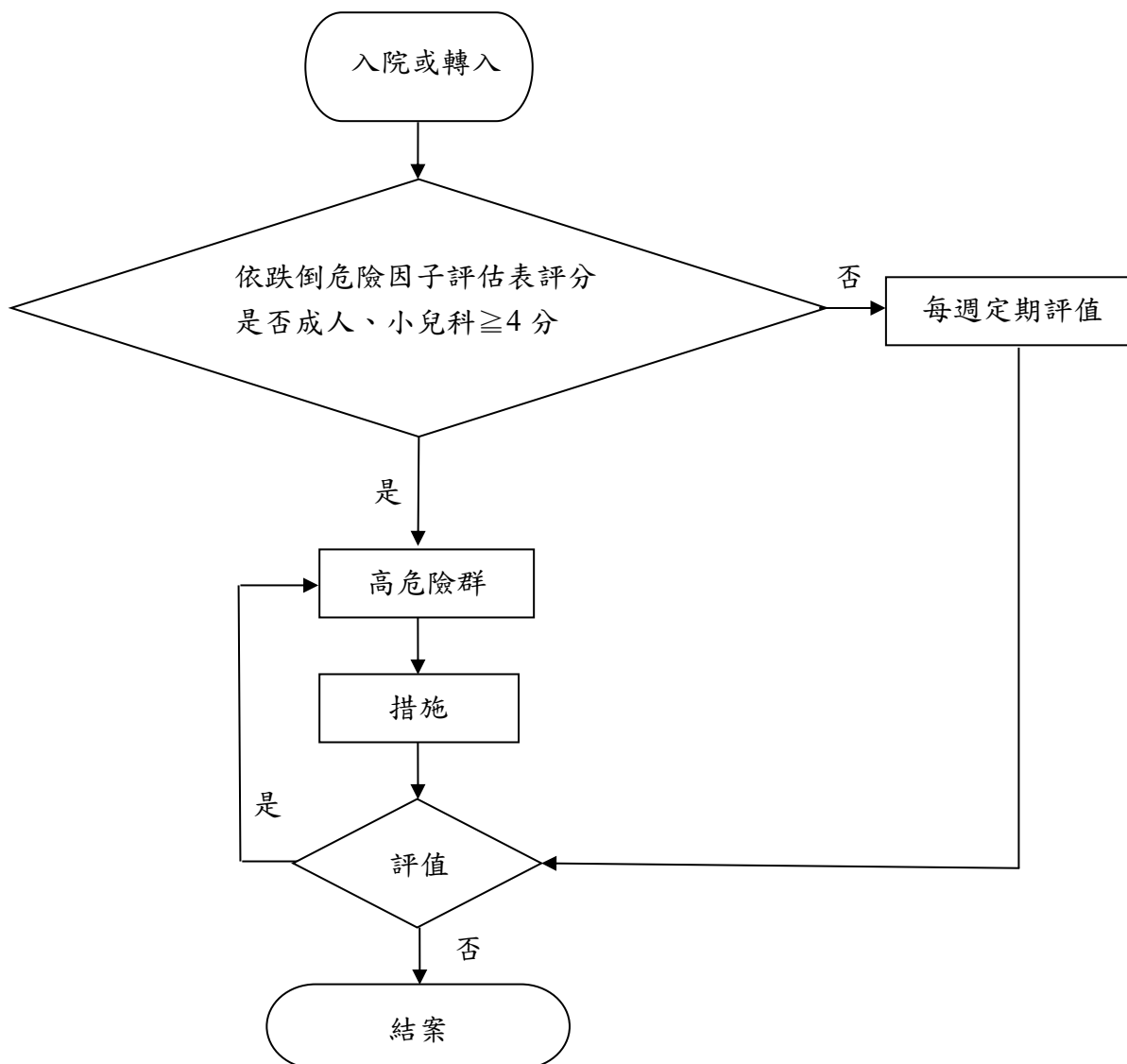
四、使用表單

(略)

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	10/16

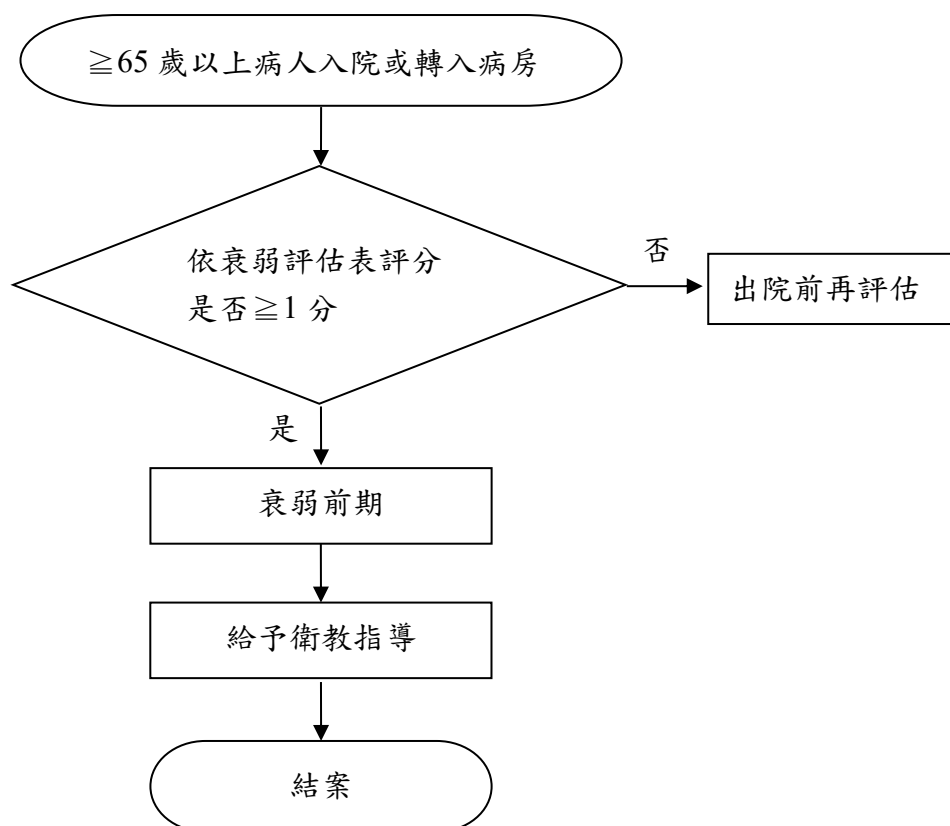
五、流程圖

跌倒危險因子評估



主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	11/16

衰弱評估



主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	12/16

六、參考資料

- (一) 林小玲、溫明寰、陳玉枝(2010)•跌倒危險評估量表準確度之研究•醫護科技期刊，12(1)，47-59。
- (二) 陳玉枝、宋素貞、馬淑清、徐紫娟、郭淑瑜、張麗銀(2003)•強化跌倒預防措施之效果評價•行政院衛生署九十二年度科技研究發展計畫，未出版。

七、附件

- (一) 附件一：防跌標語。
- (二) 附件二：防跌標語（輪椅）。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	13/16

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定	97 年 11 月 30 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.01.11	2.1	增加：(1)確認病人能正確使用叫人鈴。 (2)高危險群病人需增加探視的次數。	101 年 01 月 11 日 護理部 RCA 會議通過
101.04.18	2.2	增加：1.(4)照顧期間須特別注意的事項 2.(4)視病人情況適當調整床的高度，以降低跌倒造成的傷害性。	101 年 04 月 18 日 護理部照護標準委員會通過
101.10.03	2.3	配合本院預防跌倒須知衛教單張修訂	101 年 10 月 03 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.05.08	3.1	跌倒危險因子評估表病情改變新增：1.全麻手術後需重評跌倒評估表 2.病人入院或轉入 24 小時內改為 8 小時內 3.病人跌倒危險因子評估表刪除「不明原因」四個字，修正為最近一年曾有跌倒經驗。	102 年 05 月 08 日 護理品質管理委員會通過
102.12.09	3.2	因單位屬性考量，於流程說明備註新增復健科病人 ≥ 7 分，於病房中標示預防跌倒的標誌	102 年 12 月 09 日 護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.05	3.4	說明內容修正：小兒科 ≥ 4 分，則擬定預防高危險群跌倒措施，為病人戴上粉紅色手圈及流程圖內容同步修正。	103 年 08 月 05 日 護理部照護標準委員會通過
103.10.07	3.5	說明內容新增：為病人戴上粉紅色手圈時並告知病人為高危險群跌倒病人，容易跌倒，若跌倒嚴重度也比其他人高。	103 年 08 月 06 日 護理品質管理委員會提議；103 年 10 月 07 日護理部照護標準委員會通過

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	14/16

修正日期	版本	修正說明	備註
104.12.01	3.6	新增第三項第(二)目之 1(12)內容:除了行進中的輪椅外,未使用一定要固定,避免突然滑動,造成意外發生。	依據異常事件通報案號:AB10410001 提出修正,於 104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過
105.04.07	3.7	依據 105~106 年度醫院醫療品質及病人安全年度工作目標之目標 4、預防病人跌倒及降低傷害程度,增修第三項第(二)目之 1、2 及之 3、4 說明內容。	105 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.17	3.8	新增第三項第(二)目之 1(15)及 1(17)之內容。	105 年 08 月 17 日護理部週會決議通過
105.10.04	3.9	第三項第(二)目之 1(16)新增:衛教病人及家屬,入院時應將隨身物品例如輔具、眼鏡(如老花眼鏡)、助聽器及..等帶來醫院,方便日常活動使用,預防跌倒發生。	105 年 10 月 04 日護理部照護標準委員會通過
106.04.19	4.0	1. 第三項第(一)目之 4 刪除:8 小時內依「跌倒危險因子評估表」(表一)或「跌倒危險因子評估表—小兒科」(表二)進行評估;修改為~病人入院或轉入 8 小時內、病情改變(意識、肢體活動改變、發生跌倒、全麻手術後)由負責護理人員登入 HIS 系統跌倒危險因子評估進行評估,若無上述情況,則依評值原則每週定期評值。 2. 因表單已資訊化故刪除附件跌倒危險因子評估表及跌倒危險因子評估表—小兒科。	106 年 04 月 19 日護理長週會決議通過
107.06.13	4.1	第三項第一目之 4 新增出院前,定期評值及追蹤 新增病人出院前應重新評估。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
107.08.01	4.2	1.第三項第一目新增出院前 24 小時。 2.第三項第二目之 1 新增(19)說明。 3.第三項第二目之 5 新增出院後加強防跌衛教事項。	107 年 08 月 01 日護理部週會通過
107.10.17	4.3	1. 第二項新增(含中興分院)。 2. 第三項第二目之 1、4、5 說明內容文字修訂:家屬改為照顧者,照護人員改為護理人員。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	15/16

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.05	4.4	第三項第三目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.08.18	4.5	第三項第一目之 4 新增措施備註：核醫大樓病房 PIT 系統會顯示「跌」，故不需再貼上防跌標語。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	4.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.08.04	4.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.11	4.6	1. 第三項第一目之 4.新增內容說明。 2. 第三項第一目之 5.新增衰弱評估及內容說明。 3. 第三項第二目之 1.(19)新增內容說明。 4. 第五項流程圖新增衰弱評估。	112 年 04 月 11 日督導會議通過公布。
112.08.03	4.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	4.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	4.7	第二項：刪除：含中興分院	114 年 04 月 10 日照護標準組會議通過；114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	預防病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H02	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	16/16

修正日期	版本	修正說明	備註